



Yth.

1. PLT Kepala Bidang Pelayanan Medis
2. Kepala Bidang Umum Keuangan
3. Komite Medik
4. Asuransi Center
5. Rekam Medis – Pendaftaran
6. Instalasi Rawat Jalan
7. Instalasi Rawat Inap
8. Instalasi Gawat Darurat
9. Instalasi Kamar Operasi
10. Laboratorium
11. Radiologi

SURAT EDARAN
NOMOR : 890/I-SE/DIR/IX/2025

TENTANG
TANGGUNG JAWAB UNIT PELAYANAN PADA KELENGKAPAN DOKUMEN KLAIM
BPJS KESEHATAN

Berdasarkan Pedoman Pelayanan Nomor 304/I-PER/DIR/III/2021 tentang Pedoman Pelayanan Asuransi Center RS Prima Husada, menyebutkan bahwa kelengkapan dokumen klaim RJTL (Rawat Jalan Tingkat lanjut) dan RITL (Rawat inap tingkat lanjut) Hard / Elektronik yang harus di lengkapi oleh unit pelayanan yang terkait dengan pelayanan yang telah diberikan ke pasien BPJS Kesehatan. Berikut dokumen klaim manual/digital yang menjadi tanggung jawab unit pelayanan:

NO	UNIT	DOKUMEN		PIC
		RAWAT JALAN	RAWAT INAP	
1.	Pendaftaran	1. Surat Kontrol / Rujukan 2. SEP RJ	SEP Rawat Inap	Annisa Aulia Savira, Amd. Kes
2.	Poli Rawat Jalan	1. Resume Rawat Jalan 2. Lembar Rujuk Internal atau Konsul Internal 3. Laporan tindakan apabila ada (Laporan Phaco, Laporan ESWL, Protokol Injeksi Intraartikular, Laporan Curretage,dll) 4. Rehab Medik (Pengkajian Awal Rehab Medik, Protokol terapi Rehab medik, CPPT/ Evaluasi, form rujuk internal) 5. SITB	SPRI Rawat Inap	Fadhila Ayu Setiyani, Amd. Kep
3.	Poli Rehab Medik	1. Rehab Medik (Pengkajian Awal Rehab Medik, Protokol terapi Rehab medik,		



		CPPT/ Evaluasi, form rujuk internal)		
3.	IGD	1. Triage 2. Pengkajian Medis Awal IGD 3. Pengkajian Awal Keperawatan 4. Form rujukan 5. Form surat kematian	1. Triage 2. Pengkajian Awal IGD 3. Pengkajian Keperawatan 4. SPRI 5. Hasil Pemeriksaan Penunjang dari luar 6. Lembar perujuk (untuk bayi mohon di tulis apgar scor dengan lengkap) 7. Form rujukan 8. Form surat kematian 9. Form dehidrasi 10. Form observasi	1. Seluruh dokter IGD 2. Very Susanto, S. Kep., Ns
	IGD PONEK		Lembar Observasi dilengkapi partograph pembukaan 4	
4.	Rawat Inap		1. Pengkajian Awal DPJP 2. Ringkasan Pulang 3. Lembar Konsultasi 4. CPPT (apabila ada informasi tindakan yang dilakukan (pungsi, efusi, punksi acites, ventilator) 5. Lembar Observasi (ICU,PICU,NICU) 6. SITB 7. Form observasi 8. Form rujuk 9. Form surat kematian	Seluruh Karu Rawat inap Per Lantai
5.	IKO		1. Laporan Operasi 2. Laporan Tindakan dan Anastesi lengkap	1. Seluruh DPJP Bedah 2. Siti Durotul Ibadiyah, S. Kep., Ns
6.	Maternitas		1. Laporan Tindakan 2. Pengkajian Awal Kebidanan 3. Data Partus 4. Observasi Inpartu 5. Partograf 6. NST 7. Identifikasi Bayi Baru Lahir 8. Status Bayi 9. SHK 10. Lembar transfer (untuk bayi) 11. Form rujuk	Siti Zaimah, Amd. Keb



			12. Form surat kematian	
7.	Laboratorium	1. Hasil pemeriksaan laboratorium (pemeriksaan Internal dan Eksternal ex. PA)	1. Hasil pemeriksaan laboratorium (pemeriksaan Internal dan Eksternal ex. PA) 2. Lembar tranfusi Darah	Yoga Eka Mada Ariwa, Amd. AK
8.	Radiologi	Hasil pemeriksaan radiologi internal dan eksternal	1. Hasil basahan 2. Hasil pemeriksaan radiologi dan eksternal	Isma Mufida, Amd. Rad
9.	Kasir	Kwitansi dan rincian tagihan RJ	Kwitansi dan rincian tagihan RI	1. Nuraini Mufidah, S.E 2. Nuvi Apriska Putri
10.	DPJP	1. Memastikan diagnosis telah tegak secara klinis pada anamnesa pemeriksaan fisik penunjang dan tatalaksana pada saat visite 2. Memastikan kelengkapan dan kejelasan laporan tindakan 3. Memastikan resume medis telah di isi secara lengkap dan jelas 4. Berkomunikasi dengan DPJP penunjang jika hasil pemeriksaan penunjang dengan diagnosis klinis berbeda	1. Memastikan diagnosis telah tegak secara klinis pada anamnesa pemeriksaan fisik penunjang dan tatalaksana pada saat visite 2. Memastikan kelengkapan dan kejelasan laporan operasi untuk dpjp bedah 3. Memastikan resume medis telah di isi secara lengkap dan jelas 4. Berkomunikasi dengan DPJP penunjang jika hasil pemeriksaan penunjang dengan diagnosis klinis berbeda	Seluruh DPJP
11.	Dokter Ruangan		1. Memastikan diagnosis yang di tetapkan oleh DPJP lengkap, jelas secara anamnesa pemeriksaan fisik, penunjang dan tata laksana 2. Mengkomunikasikan ketidaklengkapan dan ketidakjelasan anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, diagnosis dan tatalaksana DPJP	dr. Amanda Firmandani



			3. Mereview ketidaklengkapan dan ketidakjelasan anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, diagnosis dan tatalaksana yang telah di perbaiki oleh DPJP 4. Mengembalikan indikasi rawat inap di triage dan assemen awal IGD ke dokter IGD apabila tidak sesuai 5. Mereview ketidaklengkapan dan ketidakjelasan anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, diagnosis dan tatalaksana yang telah diperbaiki oleh dokter IGD 6. Komunikasi dengan pihak kepala asuransi 7. Memonitoring kontrol biaya pelayanan kesehatan	
--	--	--	---	--

Catatan :

1. Dokumen Rawat Inap untuk saat menyetorkan ke Rekam medis WAJIB sudah lengkap juga untuk ERM nya disetor maksimal H+1 pasien KRS
- Untuk pasien Rawat Jalan melaporkan jumlah pasien rawat jalan yang telah terlayani pada spreadsheet disaat setelah melakukan pelayanan
2. Hasil PA wajib dilakukan Follow Up oleh Laboratorium dengan rentang waktu minimal 3 hari setelah pengiriman sampel dan maksimal 5 hari

Demikian surat edaran ini dibuat untuk diperhatikan dan dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 30 September 2025
PLT Direktur RS Prima Husada,



dr. Resti Lestantini, M. Kes